स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन

Non-Governmental Health Organizations

गैर-सरकारी संगठन की संकल्पना

गैर-सरकारी संगठन (**Non-Governmental Organization**; **NGO**) ऐसा संगठन है जो सरकारी विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था से अलग रहकर किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए काम करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में उसका कार्य सेवा, जागरूकता, प्रशिक्षण, पुनर्वास, समुदाय की भागीदारी तथा नीतिगत सुधार से जुड़ सकता है।

गैर-लाभकारी (**Non-Profit**) व्यवस्था में आय और अधिशेष संगठन के उद्देश्य पर लगाए जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि संस्था के पास आय, वेतनभोगी कर्मचारी या प्रशासनिक खर्च नहीं हो सकते।

अध्याय के प्रमुख क्षेत्र

क्षेत्र	विषय
भारतीय संगठन	रेड क्रॉस, परिवार कल्याण, रोग नियंत्रण और समुदाय
अंतरराष्ट्रीय संगठन	मानवीय सहायता, प्रजनन स्वास्थ्य और बाल कल्याण
स्वास्थ्य में योगदान	रोकथाम, सेवा तक पहुँच, शिक्षा और पुनर्वास
संगठन संचालन	योजना, समन्वय, जवाबदेही और नैतिकता

व्यापक दृष्टिकोण

स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन और पेशेवर संघ, दोनों गैर-सरकारी क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। रेड क्रॉस आंदोलन की विशिष्ट मानवीय और संस्थागत स्थिति को उसके अपने संदर्भ में समझना आवश्यक है।

> किसी संगठन को पहचानने के लिए उसका उद्देश्य, गठन, संचालन और वास्तविक कार्य एक साथ देखें।

गैर-सरकारी संगठन की पहचान

Identity of Non-Governmental Organizations

प्रमुख विशेषताएँ

- सामाजिक उद्देश्य: समुदाय के स्वास्थ्य, कल्याण या अधिकारों में योगदान।
- संगठनात्मक व्यवस्था: नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया और कार्य की जिम्मेदारियाँ।
- सरकारी विभाग से अलग संचालन: साझेदारी होने पर भी अपनी संस्थागत पहचान।
- सार्वजनिक जवाबदेही: संसाधनों और सेवाओं के उपयोग की स्पष्ट जानकारी।

स्वैच्छिकता का अर्थ

स्वैच्छिक संगठन में नागरिक अपनी इच्छा से सेवा, धन, समय या कौशल दे सकते हैं। संस्था में प्रशिक्षित और वेतनभोगी पेशेवर भी हो सकते हैं। प्रत्येक सेवा केवल स्वयंसेवकों से चलाना आवश्यक नहीं है।

अनुदान और पहचान

सरकारी अनुदान प्राप्त करना, सरकारी कार्यक्रम में सहयोग करना और सरकारी विभाग होना अलग बातें हैं। संस्था की प्रकृति उसके गठन तथा संचालन से तय होती है; केवल धन के स्रोत से नहीं।

संगठन के रूप

न्यास, सोसायटी और गैर-लाभकारी कंपनी जैसे विभिन्न रूपों में सामाजिक संगठन कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक रूप की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था होती है। सभी संगठनों की कानूनी संरचना समान मान लेना गलत है।

> **NGO** एक व्यापक पहचान है; यह हर संस्था के लिए एक ही कानूनी रूप का नाम नहीं है।

गैर-सरकारी संगठनों का वर्गीकरण

Classification of Organizations

वर्गीकरण का आधार	प्रकार	उदाहरणात्मक कार्य
कार्यक्षेत्र	स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय	गाँव की सेवा से वैश्विक सहायता तक
मुख्य उद्देश्य	स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पुनर्वास	किसी विशेष जरूरत पर काम
कार्य की प्रकृति	सेवा, प्रशिक्षण, शोध, पक्षसमर्थन	उपचार सहायता या नीति में सुधार
संगठनात्मक रूप	स्वतंत्र संस्था, संघ, महासंघ	स्वयं कार्य या सदस्य संस्थाओं का सहयोग

सेवा प्रदान करने वाला संगठन

ऐसी संस्था स्वास्थ्य केंद्र, चल चिकित्सा सेवा, परामर्श या पुनर्वास सहायता चला सकती है। सेवा का वास्तविक दायरा उपलब्ध विशेषज्ञता और संसाधनों पर निर्भर रहता है।

पक्षसमर्थन और क्षमता निर्माण

पक्षसमर्थन (**Advocacy**) में लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को नीति और व्यवस्था तक पहुँचाया जाता है। क्षमता निर्माण (**Capacity Building**) से समुदाय तथा कार्यकर्ताओं का ज्ञान और कौशल बढ़ता है।

वर्गों का संबंध

एक संस्था सेवा भी दे सकती है और स्वास्थ्य शिक्षा भी कर सकती है। “राष्ट्रीय” उसके भौगोलिक स्तर को बताता है, जबकि “रोग नियंत्रण” उसके कार्य को बताता है।

> वर्गीकरण के अलग आधारों को एक-दूसरे का विकल्प न समझें।

स्वास्थ्य में स्वैच्छिक क्षेत्र का महत्त्व

Why the Voluntary Sector Matters

सेवा और समुदाय के बीच सेतु

दूरी, गरीबी, भाषा, जानकारी की कमी और सामाजिक भेदभाव स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में बाधा बन सकते हैं। समुदाय से जुड़ा संगठन इन बाधाओं को समझकर परिवार को उचित सेवा से जोड़ सकता है।

योगदान	स्वास्थ्य पर प्रभाव
स्वास्थ्य शिक्षा	जोखिम और उपलब्ध सेवाओं की समझ
समुदाय की भागीदारी	स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्य
सेवा से जोड़ना	जाँच, उपचार और रेफरल तक पहुँच
पुनर्वास	दैनिक जीवन और सामाजिक सहभागिता में सहायता
नवाचार	स्थानीय परिस्थितियों में नई कार्यविधि का परीक्षण

समान पहुँच

समान अवसर (**Equity**) का अर्थ अलग जरूरत वाले लोगों के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। दिव्यांग व्यक्ति के लिए सुगम रास्ता और दूरस्थ परिवार के लिए परिवहन सहयोग इसके उदाहरण हैं।

सार्वजनिक व्यवस्था के साथ संबंध

स्वैच्छिक संगठन स्वास्थ्य व्यवस्था को अतिरिक्त सहयोग दे सकते हैं। व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य जिम्मेदारी और नियमन सरकार तथा संबंधित सार्वजनिक संस्थाओं से जुड़े रहते हैं।

> संस्था का मूल्य केवल सेवा की संख्या से नहीं; जरूरतमंद व्यक्ति तक उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण पहुँच से भी समझें।

रेड क्रॉस आंदोलन की संरचना

The Red Cross and Red Crescent Movement

मानवीय विचार का विकास

रेड क्रॉस का इतिहास हेनरी ड्यूनाँ (**Henry Dunant**) की युद्ध में घायल व्यक्तियों के प्रति मानवीय चिंता से जुड़ा है। 1863 में अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का गठन हुआ। आगे चलकर राष्ट्रीय सोसायटियाँ और अंतरराष्ट्रीय महासंघ विकसित हुए।

आंदोलन के तीन घटक

1	**ICRC**	संघर्ष और हिंसा में मानवीय सहायता तथा संरक्षण।
2	**IFRC**	राष्ट्रीय सोसायटियों का सहयोग, आपदा और स्वास्थ्य कार्य।
3	**राष्ट्रीय सोसायटियाँ**	अपने देश और समुदाय में मानवीय कार्य; भारत में **IRCS**।

एक आंदोलन, अलग भूमिकाएँ

अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट आंदोलन में **ICRC**, **IFRC** तथा राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसायटियाँ शामिल हैं। इनकी भूमिकाएँ संबंधित हैं, लेकिन इनके नाम और जिम्मेदारियाँ एक जैसे नहीं हैं।

भारत की राष्ट्रीय सोसायटी भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी है। इसे **ICRC** का भारतीय कार्यालय या **IFRC** का दूसरा नाम नहीं कहा जाता।

विशिष्ट स्थिति

आंदोलन के संगठन मानवीय सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं। उनकी विशेष भूमिका को सामान्य सेवा संस्था की संक्षिप्त परिभाषा में पूरी तरह समेटना उचित नहीं है।

> **ICRC**, **IFRC** और भारतीय रेड क्रॉस तीन अलग संस्थागत पहचान हैं।

अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति

International Committee of the Red Cross

परिचय

अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (**International Committee of the Red Cross**; **ICRC**) की स्थापना 1863 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह स्वतंत्र मानवीय संगठन है जिसकी प्रमुख भूमिका सशस्त्र संघर्ष और अन्य हिंसात्मक परिस्थितियों से प्रभावित लोगों की सहायता तथा संरक्षण है।

प्रमुख कार्य

- संघर्ष में घायल, बीमार और अन्य प्रभावित व्यक्तियों के लिए मानवीय सहायता।
- लागू परिस्थितियों में बंदियों के साथ व्यवहार और उनकी मानवीय जरूरतों पर कार्य।
- बिछुड़े परिवारों के बीच संपर्क तथा लापता व्यक्तियों से संबंधित सहायता।
- अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (**International Humanitarian Law**) की समझ और सम्मान को बढ़ावा।

सहायता और संरक्षण

सहायता का संबंध भोजन, पानी, चिकित्सा या आवश्यक सामग्री से हो सकता है। संरक्षण में व्यक्ति की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों से संबंधित मानवीय कार्य शामिल होते हैं।

संस्थागत पहचान

ICRC संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। जिनेवा अभिसमयों और मानवीय व्यवस्था में उसकी विशिष्ट भूमिका है। इसे **WHO** जैसी अंतरसरकारी स्वास्थ्य संस्था से अलग समझें।

> **ICRC** की पहचान संघर्ष और हिंसा से प्रभावित लोगों की मानवीय सहायता तथा संरक्षण से जुड़ी है।

अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस महासंघ

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

परिचय

अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसायटी महासंघ (**International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies**; **IFRC**) की स्थापना 1919 में पेरिस में हुई। इसका प्रारंभिक नाम League of Red Cross Societies था। इसका वर्तमान मुख्यालय जिनेवा में है।

कार्य की दिशा

IFRC राष्ट्रीय सोसायटियों के सहयोग का महासंघ है। आपदाओं, स्वास्थ्य संकटों और समुदाय की संवेदनशीलता को कम करने में राष्ट्रीय सोसायटियों की क्षमता तथा समन्वय बढ़ाना इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

क्षेत्र	योगदान
आपदा	तैयारी, राहत तथा पुनर्बहाली में सहयोग
स्वास्थ्य	सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य और संकट प्रतिक्रिया
संगठनात्मक क्षमता	प्रशिक्षण, संसाधन और संस्थागत विकास
सामुदायिक क्षमता	स्थानीय तैयारी और जोखिम में कमी

ICRC से संबंध और अंतर

ICRC का प्रमुख कार्य संघर्ष से जुड़े संरक्षण और सहायता से संबंधित है। **IFRC** राष्ट्रीय सोसायटियों के सहयोग तथा आपदा और स्वास्थ्य कार्यों में महत्वपूर्ण है। वास्तविक परिस्थितियों में घटक समन्वय करते हैं; उनकी पहचान फिर भी अलग रहती है।

> **IFRC** को राष्ट्रीय सोसायटियों का महासंघ समझें, किसी देश के स्वास्थ्य मंत्रालय का विभाग नहीं।

रेड क्रॉस के सात मूल सिद्धांत

The Seven Fundamental Principles

सिद्धांत	मूल अर्थ
मानवता (**Humanity**)	जीवन, स्वास्थ्य और मानवीय सम्मान की रक्षा
निष्पक्षता (**Impartiality**)	भेदभाव के बिना आवश्यकता के आधार पर सहायता
तटस्थता (**Neutrality**)	संघर्ष के पक्षों का समर्थन और राजनीतिक विवाद से दूरी
स्वतंत्रता (**Independence**)	मानवीय कार्य में आवश्यक स्वायत्तता
स्वैच्छिक सेवा (**Voluntary Service**)	लाभ की इच्छा से प्रेरित हुए बिना मानवीय सेवा
एकता (**Unity**)	एक देश में एक राष्ट्रीय सोसायटी, सभी के लिए खुली
सार्वभौमिकता (**Universality**)	राष्ट्रीय सोसायटियों की समान स्थिति और साझा जिम्मेदारी

निष्पक्षता और तटस्थता

निष्पक्षता बताती है कि सहायता किस आधार पर दी जाए: जरूरत और उसकी गंभीरता। तटस्थता बताती है कि संघर्ष तथा विवाद में संगठन अपनी स्थिति कैसे रखे। दोनों को समानार्थी न समझें।

स्वतंत्रता और सहयोग

सार्वजनिक अधिकारियों के साथ सहयोग करते समय भी मानवीय सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय की स्वायत्तता आवश्यक है। स्वतंत्रता का अर्थ सहयोग समाप्त करना नहीं है।

> स्वैच्छिक सेवा का सिद्धांत वेतनभोगी कर्मचारी या आवश्यक संचालन खर्च के विरुद्ध नहीं है।

भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी

Indian Red Cross Society

परिचय

भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी (**Indian Red Cross Society**; **IRCS**) की स्थापना 1920 में हुई। इसका राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना **Indian Red Cross Society Act**, 1920 के अंतर्गत हुई थी।

संगठन की प्रकृति

यह राष्ट्रीय मानवीय सोसायटी है। सार्वजनिक अधिकारियों की मानवीय सेवाओं की सहायक भूमिका (**Auxiliary Role**) और स्वतंत्र मानवीय पहचान साथ समझनी चाहिए। कानून से गठित होने के कारण इसे स्वास्थ्य मंत्रालय का साधारण विभाग मान लेना सही नहीं है।

कार्य का व्यापक क्षेत्र

- आपदा तथा संकट में राहत और आवश्यक सहायता।
- स्वास्थ्य, रक्त सेवाओं तथा समुदाय से जुड़े कार्य।
- प्राथमिक उपचार और संबंधित प्रशिक्षण।
- स्वयंसेवकों तथा युवा भागीदारी को प्रोत्साहन।

राष्ट्रीय और स्थानीय व्यवस्था

राष्ट्रीय मुख्यालय तथा राज्य और स्थानीय स्तर की शाखाएँ संगठन के कार्य में सहयोग करती हैं। किसी स्थान पर उपलब्ध सेवा का दायरा शाखा की क्षमता और कार्यक्रम के अनुसार अलग हो सकता है।

आंदोलन में स्थान

IRCS भारत की राष्ट्रीय सोसायटी है; **ICRC** और **IFRC** अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग भूमिकाओं वाले घटक हैं।

> भारतीय रेड क्रॉस की विशेष पहचान: राष्ट्रीय मानवीय सोसायटी, सार्वजनिक अधिकारियों की सहायक और सिद्धांतों के अनुसार स्वायत्त।

भारतीय रेड क्रॉस के स्वास्थ्य कार्य

Health Services of the Indian Red Cross

कार्यक्षेत्र	योगदान
रक्त सेवाएँ	रक्तदान जागरूकता और उपलब्ध व्यवस्थाओं के अनुसार सेवा
प्राथमिक उपचार	प्रशिक्षित सहायता तथा आपात सेवा से जोड़ना
स्वास्थ्य शिक्षा	स्वच्छता, रोकथाम और समुदाय की जानकारी
आपदा राहत	आवश्यक सामग्री तथा स्वास्थ्य सहयोग
युवा और स्वयंसेवक	सेवा भावना, तैयारी और सामुदायिक सहभागिता

रक्तदान और गुणवत्ता

रक्तदान की प्रेरणा महत्वपूर्ण है, पर रक्त संग्रह, जाँच, भंडारण और उपयोग प्रशिक्षित तथा अधिकृत सेवा की जिम्मेदारी है। दाता की पात्रता और सुरक्षा का आकलन संबंधित केंद्र में होता है।

प्राथमिक उपचार की भूमिका

प्राथमिक उपचार (**First Aid**) तत्काल प्रारंभिक सहायता है। इसका उद्देश्य स्थिति को बिगड़ने से रोकना और व्यक्ति को उचित चिकित्सा तक पहुँचाना है। यह हर परिस्थिति में पूर्ण उपचार का स्थान नहीं लेता।

परिवार और समुदाय

परिवार रक्तदान के प्रति सही जानकारी, आपदा तैयारी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी से सहयोग कर सकते हैं। सहायता व्यक्ति की वास्तविक जरूरत और सम्मान को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए।

> स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता के लिए सेवा भावना और तकनीकी दक्षता दोनों आवश्यक हैं।

सेंट जॉन एम्बुलेंस, भारत

St John Ambulance in India

परिचय

सेंट जॉन एम्बुलेंस (**St John Ambulance**) प्राथमिक उपचार, संबंधित प्रशिक्षण और स्वैच्छिक सहायता से जुड़ा संगठन है। भारत में **Association** की स्थापना 1912 और **Brigade** की स्थापना 1928 में हुई।

Association और Brigade

पक्ष	प्रमुख दिशा
Association	प्राथमिक उपचार तथा संबंधित विषयों का प्रशिक्षण
Brigade	प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा संगठित स्वैच्छिक सहायता

प्रमुख योगदान

- प्राथमिक उपचार के ज्ञान और कौशल का विकास।
- घर, विद्यालय, कार्यस्थल और सार्वजनिक कार्यक्रमों में तैयारी।
- प्रशिक्षित सहायता तथा उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार एम्बुलेंस सहयोग।
- सेवा के दौरान अनुशासन, सुरक्षित व्यवहार और उचित रेफरल।

प्रशिक्षण का महत्त्व

केवल पुस्तक पढ़ लेना व्यावहारिक दक्षता का पूरा विकल्प नहीं है। कौशल का अभ्यास, प्रशिक्षण और समय पर पुनः प्रशिक्षण आवश्यक होते हैं। सहायता देने वाले को अपनी क्षमता की सीमा पहचाननी चाहिए।

भारतीय संदर्भ

भारत में सेंट जॉन एम्बुलेंस का कार्य भारतीय रेड क्रॉस के साथ संस्थागत संबंध रखता है। प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण और अस्पताल की विशेषज्ञ चिकित्सा अलग स्तर की सेवाएँ हैं।

> स्थापना वर्ष बताते समय **Association** और **Brigade** की अलग पहचान स्पष्ट रखें।

भारतीय परिवार नियोजन संघ

Family Planning Association of India

परिचय

भारतीय परिवार नियोजन संघ (**Family Planning Association of India**; **FPA India**) की स्थापना 1949 में हुई। यह गैर-सरकारी संगठन यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों (**Sexual and Reproductive Health and Rights**; **SRHR**) के क्षेत्र में कार्य करता है।

कार्य की दिशा

- परिवार नियोजन की जानकारी और स्वैच्छिक निर्णय में सहायता।
- प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएँ।
- महिलाओं, युवाओं और सेवा से वंचित समूहों तक पहुँच।
- स्वास्थ्य शिक्षा, क्षमता निर्माण और अधिकारों के लिए पक्षसमर्थन।

परिवार नियोजन का अर्थ

परिवार नियोजन का संबंध संतान के बारे में जानकारी के आधार पर निर्णय लेने और उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच से है। इसे केवल जन्म संख्या कम करने की गतिविधि समझना अधूरा दृष्टिकोण है।

स्वैच्छिक और सूचित निर्णय

व्यक्ति को विकल्प, लाभ, सीमाएँ और सेवा से संबंधित जानकारी समझने योग्य भाषा में मिलनी चाहिए। निर्णय दबाव, भेदभाव या बाध्यता पर आधारित नहीं होना चाहिए। गोपनीयता तथा सम्मान महत्वपूर्ण हैं।

स्पष्ट अंतर

FPA India की स्थापना 1949 और भारत के राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का आरंभ 1952 अलग घटनाएँ हैं। संघ और सरकारी कार्यक्रम एक संस्था नहीं हैं।

> प्रजनन स्वास्थ्य में जानकारी, स्वैच्छिक निर्णय, गोपनीयता और उचित सेवा साथ आवश्यक हैं।

अंतरराष्ट्रीय नियोजित पितृत्व महासंघ

International Planned Parenthood Federation

परिचय

अंतरराष्ट्रीय नियोजित पितृत्व महासंघ (**International Planned Parenthood Federation**; **IPPF**) की स्थापना 1952 में बंबई, वर्तमान मुंबई, में तीसरे अंतरराष्ट्रीय नियोजित पितृत्व सम्मेलन के दौरान हुई। यह सदस्य संघों का अंतरराष्ट्रीय महासंघ है।

प्रमुख उद्देश्य

IPPF का कार्य यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, अधिकारों और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच से जुड़ा है। स्थानीय सदस्य संघ अपने संदर्भ में सेवाएँ, शिक्षा और पक्षसमर्थन का कार्य करते हैं।

स्तर	भूमिका
अंतरराष्ट्रीय महासंघ	साझा दिशा, सहयोग और क्षमता निर्माण
सदस्य संघ	स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्यक्रम
समुदाय	जानकारी, सहभागिता और सेवा का उपयोग

भारत से संबंध

भारत का परिवार नियोजन संघ **IPPF** के संस्थापक सदस्य संघों में शामिल था। **FPA India** और **IPPF** के संबंध को राष्ट्रीय सदस्य संघ तथा अंतरराष्ट्रीय महासंघ के रूप में समझना उपयोगी है।

अन्य संस्थाओं से अंतर

IPPF गैर-सरकारी महासंघ है। **UNFPA** संयुक्त राष्ट्र तंत्र का कोष है। दोनों प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े होने पर भी एक ही संगठन या एक ही संस्थागत वर्ग नहीं हैं।

> 1949: **FPA India**; 1952: **IPPF** - स्थापना वर्ष और संस्थागत स्तर अलग हैं।

भारतीय क्षयरोग संघ

Tuberculosis Association of India

परिचय

भारतीय क्षयरोग संघ (**Tuberculosis Association of India**; **TAI**) की स्थापना 1939 में हुई। यह क्षयरोग से संबंधित स्वैच्छिक संगठन है, जिसका कार्य जागरूकता, प्रशिक्षण तथा रोग नियंत्रण प्रयासों में सहयोग से जुड़ा है।

प्रमुख योगदान

- क्षयरोग के प्रति सही जानकारी और सामाजिक जागरूकता।
- संबंधित संस्थाओं तथा पेशेवरों के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान।
- रोग नियंत्रण कार्य में स्वैच्छिक सहभागिता और सहयोग।
- **TB** Seal अभियान जैसे प्रयासों के माध्यम से जनभागीदारी।

रोग नियंत्रण का सामाजिक पक्ष

क्षयरोग का उपचार केवल दवा मिलने तक सीमित नहीं है। व्यक्ति को जाँच तक पहुँच, उपचार का पालन, पोषण संबंधी सहयोग तथा भेदभाव से सुरक्षा भी चाहिए। स्वैच्छिक संस्था इन सामाजिक बाधाओं को कम करने में भूमिका निभा सकती है।

सरकारी कार्यक्रम से अंतर

राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम (**National Tuberculosis Elimination Programme**; **NTEP**) सरकारी कार्यक्रम है। **TAI** स्वैच्छिक संघ है। संघ की गतिविधियाँ सार्वजनिक सेवाओं के साथ सहयोग कर सकती हैं।

परिवार की भूमिका

संदिग्ध व्यक्ति को योग्य सेवा से जोड़ना और उपचार कर रहे व्यक्ति को सम्मानपूर्वक सहयोग देना आवश्यक है। रोग की जानकारी को सार्वजनिक करके उसे कलंकित करना उचित नहीं है।

> क्षयरोग संघ और राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम की पहचान अलग रखें।

हिंद कुष्ठ निवारण संघ

Hind Kusht Nivaran Sangh

परिचय

हिंद कुष्ठ निवारण संघ (**Hind Kusht Nivaran Sangh**; **HKNS**), जिसे **Indian Leprosy Association** भी कहा जाता है, भारत में कुष्ठ रोग से जुड़े स्वैच्छिक और सामाजिक प्रयासों का महत्वपूर्ण संगठन है।

कार्य की व्यापक दिशा

कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता, प्रभावित व्यक्तियों के प्रति सहयोग तथा संबंधित स्वैच्छिक प्रयासों के समन्वय का महत्त्व इस संगठन के संदर्भ में समझा जाता है। कुष्ठ निवारण केवल रोग की जानकारी देने तक सीमित नहीं; सामाजिक उपेक्षा और भेदभाव को कम करना भी आवश्यक है।

सहायता के प्रमुख आयाम

आयाम	आवश्यक सहयोग
पहचान और सेवा	व्यक्ति को उचित जाँच तथा उपचार से जोड़ना
सामाजिक जानकारी	मिथक, डर और कलंक कम करना
पुनर्वास	दैनिक जीवन, कार्य और सहभागिता में सहायता
समन्वय	सार्वजनिक सेवा और स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग

उपचार और सम्मान

कुष्ठ रोग उपचार योग्य है। योग्य स्वास्थ्य सेवा से समय पर उपचार और आवश्यक देखभाल महत्वपूर्ण हैं। प्रभावित व्यक्ति को परिवार, विद्यालय या कार्यस्थल से स्वतः अलग कर देना उचित सामाजिक प्रतिक्रिया नहीं है।

संस्था और कार्यक्रम

HKNS स्वैच्छिक संगठन है; राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है। दोनों के नाम समान विषय से जुड़े हैं, पर संस्थागत पहचान अलग है।

> व्यक्ति को रोग के नाम से पहचानने के बजाय उसके स्वास्थ्य, सम्मान और अवसरों पर ध्यान दें।

कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट

Kasturba Gandhi National Memorial Trust

परिचय

कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट (**Kasturba Gandhi National Memorial Trust**; **KGNMT**) की स्थापना 1945 में हुई। इसका इतिहास महात्मा गांधी के नेतृत्व में कस्तूरबा गांधी की स्मृति से जुड़े राष्ट्रीय प्रयास से संबंधित है।

कार्य की दिशा

ट्रस्ट का प्रमुख संबंध ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के कल्याण से है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और ग्राम जीवन की जरूरतों को एक साथ समझना इसकी कार्य-दृष्टि का महत्वपूर्ण भाग है।

क्षेत्र	स्वास्थ्य से संबंध
महिला कल्याण	स्वास्थ्य जानकारी, सहयोग और सशक्तीकरण
बाल कल्याण	देखभाल, पोषण और विकास से जुड़ी जरूरतें
ग्रामीण विकास	जीवन परिस्थितियों और स्थानीय क्षमता में सुधार
शिक्षा तथा प्रशिक्षण	ज्ञान, कौशल और स्वावलंबन

समग्र दृष्टिकोण

ग्रामीण महिला की स्वास्थ्य समस्या केवल अस्पताल की दूरी से नहीं जुड़ती। भोजन, शिक्षा, आय, काम का बोझ और निर्णय लेने की क्षमता भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। सामाजिक विकास और स्वास्थ्य का संबंध इसी कारण महत्वपूर्ण है।

स्थानीय स्तर पर कार्य

सेवा और प्रशिक्षण का वास्तविक स्वरूप स्थान तथा कार्यक्रम के अनुसार बदल सकता है। किसी एक केंद्र की गतिविधि को सभी केंद्रों पर समान रूप से लागू मानना सही नहीं है।

> महिला और बाल कल्याण में स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास परस्पर जुड़े क्षेत्र हैं।

भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ

Voluntary Health Association of India

परिचय

भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ (**Voluntary Health Association of India**; **VHAI**) की स्थापना 1970 में हुई। यह गैर-लाभकारी संगठन और स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघों का महासंघ है। इसका कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य नीति में योगदान से जुड़ा है।

प्रमुख कार्यक्षेत्र

- समुदाय की जरूरत और भागीदारी पर आधारित स्वास्थ्य प्रयास।
- स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना और जागरूकता।
- स्वैच्छिक संस्थाओं तथा कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य विषयों पर शोध, संवाद और पक्षसमर्थन।

महासंघ का अर्थ

महासंघ (**Federation**) सदस्य संस्थाओं को सहयोग, साझा मंच और अनुभवों के आदान-प्रदान की व्यवस्था देता है। यह हर सदस्य संस्था की सभी स्थानीय गतिविधियों का एक ही कार्यालय से संचालन होना नहीं दर्शाता।

सामुदायिक स्वास्थ्य दृष्टि

व्यक्ति के व्यवहार के साथ सुरक्षित पर्यावरण, सेवा की उपलब्धता और सामाजिक परिस्थितियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। केवल “व्यक्ति अपनी आदत बदले” कहना हर स्वास्थ्य समस्या का पर्याप्त समाधान नहीं है।

नीति में योगदान

समुदाय का अनुभव और प्रमाण स्वास्थ्य नीति के सुधार के लिए उपयोगी होते हैं। स्वैच्छिक संस्था जरूरत को सामने ला सकती है तथा सार्वजनिक व्यवस्था से संवाद कर सकती है।

> **VHAI** की प्रमुख पहचान स्वैच्छिक स्वास्थ्य संस्थाओं के सहयोग, सामुदायिक स्वास्थ्य और पक्षसमर्थन से जुड़ी है।

भारतीय चिकित्सा संघ

Indian Medical Association

परिचय

भारतीय चिकित्सा संघ (**Indian Medical Association**; **IMA**) का गठन 1928 में हुआ। यह आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा से जुड़े चिकित्सकों का स्वैच्छिक पेशेवर संगठन है।

प्रमुख योगदान

चिकित्सकों के बीच पेशेवर संवाद, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता तथा स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर सहभागिता इसके कार्य में शामिल हो सकती है। पेशेवर संघ सदस्यों के सामूहिक दृष्टिकोण और अनुभव को सामने लाता है।

पेशेवर संघ और नियामक

आधार	IMA	NMC
प्रकृति	स्वैच्छिक पेशेवर संघ	सांविधिक नियामक निकाय
प्रमुख संबंध	चिकित्सकों की पेशेवर सहभागिता	चिकित्सा शिक्षा और पेशे का नियमन
सदस्यता की भूमिका	संघ की संगठनात्मक भागीदारी	नियामक व्यवस्था से अलग अवधारणा

आवश्यक अंतर

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (**National Medical Commission**; **NMC**) की नियामक भूमिका और **IMA** की संघीय भूमिका अलग हैं। **IMA** की सदस्यता को चिकित्सकीय पंजीकरण या वैधानिक अनुमति का विकल्प नहीं माना जाता।

व्यापक गैर-सरकारी क्षेत्र

IMA को हर सेवा देने वाले **NGO** के समान समझना आवश्यक नहीं है। यह गैर-सरकारी पेशेवर संघ है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में अलग प्रकार का योगदान देता है।

> पेशेवर संघ, प्रशिक्षण संस्था और नियामक निकाय की पहचान अलग-अलग करें।

भारतीय बाल कल्याण परिषद

Indian Council for Child Welfare

परिचय

भारतीय बाल कल्याण परिषद (**Indian Council for Child Welfare**; **ICCW**) की स्थापना 1952 में हुई। यह बच्चों के कल्याण से जुड़ा गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन है। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है।

बाल कल्याण की व्यापक संकल्पना

बच्चे का कल्याण भोजन और रोग उपचार तक सीमित नहीं है। सुरक्षित वातावरण, देखभाल, शिक्षा, संरक्षण और विकास के अवसर भी महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों का स्वास्थ्य के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध है।

प्रमुख योगदान की दिशा

- बच्चों की जरूरतों और अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता।
- कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों के लिए सहयोग।
- शिक्षा और विकास से जुड़े अवसरों में सहायता।
- संबंधित परिषदों तथा संस्थाओं के सहयोग से बाल कल्याण कार्य।

स्वास्थ्य से संबंध

असुरक्षा, उपेक्षा और शिक्षा से वंचित होना बच्चे के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए बाल कल्याण संस्था का योगदान कभी प्रत्यक्ष सेवा और कभी सामाजिक परिस्थिति में सुधार के रूप में होता है।

नाम से भ्रम न करें

ICCW गैर-सरकारी परिषद है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (**NCPCR**) की सरकारी सांविधिक भूमिका इससे अलग है। दोनों को एक संस्था नहीं कहा जा सकता।

> बाल स्वास्थ्य को पोषण, संरक्षण, शिक्षा और विकास से जोड़कर समझें।

हेल्पएज इंडिया

HelpAge India

परिचय

हेल्पएज इंडिया (**HelpAge India**) की स्थापना 1978 में हुई। यह गैर-लाभकारी संगठन वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण, जीवन की गुणवत्ता और सम्मान से संबंधित कार्य करता है।

प्रमुख कार्यक्षेत्र

क्षेत्र	योगदान की दिशा
स्वास्थ्य	सेवा तक पहुँच तथा स्वास्थ्य सहयोग
वृद्ध देखभाल	दैनिक जरूरत और देखभाल संबंधी सहायता
आजीविका	आर्थिक सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता का सहयोग
अधिकार और जागरूकता	वृद्ध व्यक्तियों की जरूरतों को सामने लाना
संकट	आपदा से प्रभावित वृद्ध व्यक्तियों का सहयोग

वृद्धावस्था की विविध जरूरतें

सभी वृद्ध व्यक्तियों की स्थिति समान नहीं होती। कुछ स्वतंत्र रहते हैं, कुछ को चलने-फिरने, दवा, भोजन, आर्थिक सहयोग या नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है। सहायता व्यक्ति के अनुसार तय होनी चाहिए।

परिवार की भागीदारी

सुनना, निर्णय में शामिल करना, चिकित्सकीय सेवा से जोड़ना और सामाजिक संपर्क बनाए रखना देखभाल का महत्वपूर्ण भाग है। वृद्ध व्यक्ति को केवल सहायता प्राप्त करने वाला निष्क्रिय व्यक्ति मानना उचित नहीं है।

> वृद्ध कल्याण में स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक सुरक्षा, सहभागिता और गरिमा साथ महत्वपूर्ण हैं।

CARE और स्वास्थ्य से जुड़ा विकास

CARE: Humanitarian Relief and Development

परिचय और इतिहास

CARE का आरंभ 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध के बाद राहत की जरूरतों के संदर्भ में हुआ। इसका प्रारंभिक नाम **Cooperative for American Remittances to Europe** था। आगे इसका कार्य राहत से बढ़कर गरीबी और सामाजिक विकास के व्यापक क्षेत्रों तक पहुँचा।

कार्य की प्रमुख दिशा

- संकट और आपदा में मानवीय सहायता।
- भोजन, पोषण और सुरक्षित पानी से जुड़ा सहयोग।
- स्वास्थ्य तथा आवश्यक सेवाओं तक पहुँच।
- महिलाओं और लड़कियों के अवसर तथा सशक्तीकरण।
- आजीविका और दीर्घकालीन विकास।

स्वास्थ्य और गरीबी का संबंध

कम आय, असुरक्षित पानी, अपर्याप्त भोजन और सेवा तक पहुँच की बाधाएँ एक-दूसरे को बढ़ा सकती हैं। विकास आधारित स्वास्थ्य कार्य इन संबंधित कारणों पर ध्यान देता है।

संगठनात्मक पहचान

CARE नाम का उपयोग संबंधित राष्ट्रीय संगठनों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग व्यवस्था में होता है। किसी एक राष्ट्रीय संगठन के स्थापना वर्ष को हर देश की संस्था या प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय संरचना का गठन वर्ष न मानें।

राहत से दीर्घकालीन क्षमता तक

आपदा में भोजन पहुँचाना तत्काल जरूरत है। सुरक्षित जल व्यवस्था, स्थानीय कौशल और आजीविका में सुधार परिवार को भविष्य के संकट से सामना करने की क्षमता दे सकते हैं।

> **CARE** को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं, गैर-सरकारी मानवीय और विकास क्षेत्र की पहचान के रूप में समझें।

मेदसाँ साँ फ्रोंतिएर

Médecins Sans Frontières

परिचय

मेदसाँ साँ फ्रोंतिएर (**Médecins Sans Frontières**; **MSF**) को **Doctors Without Borders** भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1971 में पेरिस में चिकित्सकों और पत्रकारों द्वारा हुई। यह अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र चिकित्सा मानवीय संगठन है।

कार्य की दिशा

MSF संघर्ष, महामारी, आपदा और स्वास्थ्य सेवा से वंचित होने जैसी परिस्थितियों में चिकित्सा सहायता देता है। कार्य का स्वरूप परिस्थिति के अनुसार चिकित्सा देखभाल, आपात सेवा या संबंधित स्वास्थ्य सहयोग हो सकता है।

प्रमुख आधार

आधार	अर्थ
चिकित्सा नैतिकता	व्यक्ति की जरूरत और उचित पेशेवर देखभाल
निष्पक्षता	सहायता में भेदभाव से बचना
स्वतंत्रता	कार्य की मानवीय और चिकित्सकीय दिशा बनाए रखना
तटस्थता	संघर्ष में किसी पक्ष के समर्थन से दूरी

विशेषज्ञता और सुरक्षा

गंभीर संकट में चिकित्सा सेवा के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी, दवाएँ, उपकरण, संक्रमण नियंत्रण और कार्य की सुरक्षित व्यवस्था आवश्यक हैं। केवल राहत सामग्री पहुँचाना तथा विशेषज्ञ चिकित्सा देना अलग गतिविधियाँ हैं।

पहचान का अंतर

MSF रेड क्रॉस आंदोलन का घटक या **WHO** का विभाग नहीं है। विभिन्न संगठन एक ही संकट में काम कर सकते हैं, पर उनकी संस्थागत पहचान अलग रहती है।

> **MSF** की मुख्य पहचान कठिन परिस्थितियों में स्वतंत्र चिकित्सा मानवीय सहायता है।

सेव द चिल्ड्रेन

Save the Children

परिचय

सेव द चिल्ड्रेन (**Save the Children**) का इतिहास 1919 में लंदन में **Save the Children Fund** की स्थापना से जुड़ा है। एग्लैन्टाइन जेब (**Eglantyne Jebb**) इसके इतिहास की प्रमुख संस्थापक व्यक्तित्व थीं। यह बच्चों के कल्याण से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी आंदोलन है।

प्रमुख कार्यक्षेत्र

- बाल स्वास्थ्य और पोषण।
- शिक्षा और विकास के अवसर।
- हिंसा, शोषण तथा असुरक्षा से संरक्षण।
- आपात स्थिति में बच्चों तथा परिवारों का सहयोग।

बाल-केंद्रित दृष्टिकोण

बच्चे की आयु, स्वास्थ्य, परिवार की स्थिति और सुरक्षा की जरूरत के अनुसार सेवा तय होनी चाहिए। बच्चे को केवल छोटे वयस्क के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है।

पोषण और संरक्षण

भोजन उपलब्ध होने के साथ देखभाल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षित वातावरण भी आवश्यक हैं। विस्थापन या आपदा में परिवार से अलग होना बच्चे की कई जरूरतों को एक साथ प्रभावित कर सकता है।

UNICEF से अंतर

UNICEF संयुक्त राष्ट्र का कोष है। **Save the Children** गैर-सरकारी पहचान वाला आंदोलन है। दोनों बाल कल्याण में योगदान देते हैं, लेकिन संस्था की प्रकृति और संरचना अलग हैं।

> बाल कल्याण में जीवित रहना, स्वास्थ्य, विकास और संरक्षण परस्पर जुड़े उद्देश्य हैं।

लेप्रा सोसायटी

LEPRA Society

परिचय

लेप्रा सोसायटी (**LEPRA Society**) भारत में 1989 में स्थापित स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है। इसका कार्य वंचित समुदायों की स्वास्थ्य जरूरतों तथा कुष्ठ रोग सहित चयनित रोगों से प्रभावित व्यक्तियों के सहयोग से जुड़ा है।

प्रमुख कार्य की दिशा

कुष्ठ रोग और संबंधित दिव्यांगता, लिम्फैटिक फाइलेरियासिस, क्षयरोग, **HIV** से जुड़े सहयोग और नेत्र स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में इसके कार्यक्रम रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध कार्य का स्वरूप स्थान और कार्यक्रम के अनुसार बदल सकता है।

कार्य का आयाम	महत्त्व
समय पर सेवा	पहचान, जाँच और उपचार से जोड़ना
दिव्यांगता की रोकथाम	आवश्यक देखभाल और कौशल का सहयोग
पुनर्वास	दैनिक जीवन और सामाजिक सहभागिता
सामाजिक समावेशन	भेदभाव तथा बहिष्कार को कम करना

रोग से आगे की जरूरत

रोग का निदान व्यक्ति की शिक्षा, आजीविका और पारिवारिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य सेवा के साथ सम्मान और समावेशन आवश्यक हैं।

ऐतिहासिक पहचान

भारत की **LEPRA Society** का 1989 में गठन और पुराने अंतरराष्ट्रीय कुष्ठ राहत कार्य का इतिहास अलग घटनाएँ हैं। इन्हें एक ही स्थापना तिथि न समझें।

> पुनर्वास में शरीर की कार्यक्षमता और सामाजिक अवसर, दोनों पर ध्यान दिया जाता है।

महिला, बाल स्वास्थ्य और पोषण में भूमिका

Women, Children and Nutrition

संबंधित जरूरतें

महिला और बच्चे के स्वास्थ्य में पोषण, जानकारी, सुरक्षित देखभाल, स्वास्थ्य सेवा और परिवार का सहयोग महत्वपूर्ण हैं। गैर-सरकारी संगठन परिवार तथा उपलब्ध सेवा के बीच संपर्क बढ़ा सकते हैं।

क्षेत्र	संभावित सहयोग
मातृ स्वास्थ्य	सेवा की जानकारी और समय पर रेफरल
शिशु तथा बाल स्वास्थ्य	देखभाल और उपलब्ध सेवाओं से जोड़ना
पोषण	स्थानीय भोजन की जानकारी और सहायता से संपर्क
किशोर स्वास्थ्य	आयु के अनुरूप जानकारी और परामर्श
अधिकार	सम्मान, स्वैच्छिक निर्णय और भेदभाव से सुरक्षा

परिवार में निर्णय

महिला की जरूरत और राय को निर्णय में शामिल करना आवश्यक है। सेवा का उपयोग केवल परिवार के अन्य सदस्य की अनुमति या पसंद का विषय मानना उसकी स्वास्थ्य जरूरत को कमजोर कर सकता है।

संस्था का चयन

FPA India का प्रमुख संबंध प्रजनन स्वास्थ्य से, **ICCW** और **Save the Children** का बाल कल्याण से तथा **KGNMT** का ग्रामीण महिला-बाल विकास से है। उद्देश्य समान दिखने पर भी विशेषज्ञता अलग हो सकती है।

> उपयुक्त सहायता वही है जो परिवार को आवश्यक सेवा तक पहुँचाए और व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करे।

रोग नियंत्रण और पुनर्वास में भूमिका

Disease Control and Rehabilitation

रोग नियंत्रण में सामाजिक सहयोग

रोग की पहचान, जाँच और उपचार स्वास्थ्य सेवा के महत्वपूर्ण कार्य हैं। जानकारी की कमी, डर, दूरी और आर्थिक कठिनाई के कारण व्यक्ति सेवा तक नहीं पहुँच पाता। स्वैच्छिक संगठन इन बाधाओं पर काम कर सकते हैं।

कार्य के स्तर

स्तर	संभावित योगदान
रोग से पहले	जागरूकता और जोखिम कम करने का सहयोग
संदेह होने पर	उचित जाँच तथा सेवा की जानकारी
उपचार के दौरान	सहमति के अनुसार पालन और सामाजिक सहयोग
उपचार के बाद	कार्यक्षमता, देखभाल और पुनर्वास

संबंधित संगठन

TAI क्षयरोग, **HKNS** कुष्ठ रोग और **LEPRA Society** चयनित रोगों तथा पुनर्वास से जुड़े उदाहरण हैं। संगठन की विशिष्टता समझकर सहयोग का क्षेत्र तय करना चाहिए।

चिकित्सा की सीमा

स्वयंसेवक रोग का अंतिम निदान, दवा बदलना या उपचार समाप्त करने का निर्णय अपनी ओर से नहीं करते। ऐसे निर्णय योग्य स्वास्थ्य पेशेवर और संबंधित सेवा व्यवस्था से जुड़े हैं।

कलंक कम करना

सहयोग पाने के लिए व्यक्ति को रोग की पहचान सार्वजनिक करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। गोपनीयता से व्यक्ति का विश्वास तथा सेवा का उपयोग बेहतर हो सकता है।

> रोग नियंत्रण में चिकित्सा सेवा और सामाजिक समर्थन एक-दूसरे के पूरक हैं।

वृद्ध और दिव्यांग व्यक्तियों का सहयोग

Support for Older Persons and Persons with Disabilities

व्यक्ति-केंद्रित सहायता

आयु या दिव्यांगता देखकर सभी के लिए एक ही सहायता तय करना उचित नहीं है। व्यक्ति की क्षमता, प्राथमिकता, वातावरण और आवश्यक समर्थन का आकलन करना चाहिए।

जरूरत	सहयोग का उदाहरण
सेवा तक पहुँच	सुगम केंद्र और परिवहन की व्यवस्था
दैनिक जीवन	आवश्यक देखभाल और उपयुक्त सहायक साधन
आर्थिक स्थिति	पात्र सहायता और सेवाओं की जानकारी
सामाजिक संपर्क	सहभागिता, साथ और अकेलेपन में सहयोग
सम्मान	निर्णय में भागीदारी और भेदभाव से सुरक्षा

परिवार और देखभालकर्ता

देखभालकर्ता को उचित जानकारी, कौशल और आराम की आवश्यकता हो सकती है। परिवार का सहयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता को जितना संभव हो बनाए रखने में सहायक होना चाहिए।

संबंधित संगठन

HelpAge India वृद्ध कल्याण का प्रमुख उदाहरण है। **LEPRA Society** जैसी संस्थाओं के कार्य में रोग से जुड़ी दिव्यांगता और पुनर्वास का सहयोग शामिल हो सकता है।

सुगमता का अर्थ

सुगमता (**Accessibility**) केवल रैंप तक सीमित नहीं है। समझने योग्य सूचना, आवश्यक भाषा, सुविधाजनक समय और सेवा का सम्मानपूर्ण व्यवहार भी महत्वपूर्ण हैं।

> देखभाल का उद्देश्य सुरक्षा के साथ अधिकतम संभव स्वतंत्रता और सहभागिता बनाए रखना है।

स्वास्थ्य शिक्षा और जनभागीदारी

Health Education and Participation

स्वास्थ्य शिक्षा की प्रक्रिया

स्वास्थ्य शिक्षा (**Health Education**) केवल सूचना देना नहीं है। व्यक्ति को बात समझने, अपनी समस्या बताने और व्यवहार में आवश्यक बदलाव करने का अवसर भी मिलना चाहिए।

प्रभावी संचार

- स्थानीय भाषा और परिचित उदाहरणों का उपयोग।
- सही और आवश्यकता के अनुरूप संदेश।
- लोगों की शंकाओं तथा बाधाओं को सुनना।
- व्यवहार के लिए उपलब्ध सुविधा और संसाधन से संबंध।
- गलत जानकारी का सम्मानपूर्वक सुधार।

जानकारी से व्यवहार तक

हाथ धोने का संदेश तभी व्यावहारिक है जब पानी, साबुन और उचित स्थान भी उपलब्ध हों। केवल संदेश दोहराने से संसाधन की कमी समाप्त नहीं होती।

समुदाय की भागीदारी

समुदाय को योजना, कार्य और समीक्षा में शामिल करना सहभागिता (**Participation**) है। केवल कार्यक्रम में लोगों की उपस्थिति को पूर्ण भागीदारी नहीं कहा जा सकता।

पक्षसमर्थन

व्यक्तिगत जानकारी से आगे बढ़कर सुरक्षित जल, सुगम सेवा या बेहतर व्यवस्था की जरूरत को निर्णयकर्ताओं तक पहुँचाना पक्षसमर्थन है।

> उपयोगी स्वास्थ्य शिक्षा जानकारी, संवाद और व्यवहार के लिए आवश्यक परिस्थितियों को जोड़ती है।

आपदा और मानवीय सहायता

Disasters and Humanitarian Assistance

आपदा में स्वास्थ्य की जरूरत

आपदा के बाद चोट, विस्थापन, असुरक्षित पानी, भोजन की कमी और नियमित उपचार में बाधा जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। सहायता का चयन जोखिम और तत्काल जरूरत के अनुसार किया जाता है।

चरण	कार्य की दिशा
तैयारी	प्रशिक्षण, संपर्क और आवश्यक संसाधनों की योजना
प्रतिक्रिया	प्राथमिक सहायता, राहत और उचित रेफरल
पुनर्बहाली	सेवा, जीवन परिस्थितियों और आजीविका का सहयोग
जोखिम में कमी	भविष्य की आपदा के प्रभाव को कम करना

संगठनों की भूमिका

रेड क्रॉस आंदोलन, **CARE**, **MSF** और **Save the Children** संकट में अलग विशेषज्ञताओं से योगदान दे सकते हैं। सभी संगठन हर आपदा में एक जैसा या सभी प्रकार का कार्य नहीं करते।

समन्वय

स्थानीय प्रशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सहायता संस्थाओं के साथ जानकारी और जिम्मेदारियाँ साझा करना आवश्यक है। इससे अनावश्यक दोहराव और सेवा से छूटे समूह की समस्या कम हो सकती है।

सम्मानपूर्ण सहायता

राहत की जरूरत व्यक्ति की राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक पहचान से अलग आंकी जानी चाहिए। सहायता देते समय सुरक्षा और गरिमा का ध्यान रखें।

> संकट में गति के साथ सही प्राथमिकता, गुणवत्ता और समन्वय भी आवश्यक हैं।

सरकारी और गैर-सरकारी सहयोग

Government and Non-Governmental Cooperation

पक्ष	सार्वजनिक व्यवस्था	गैर-सरकारी क्षेत्र
प्रमुख आधार	सार्वजनिक जिम्मेदारी और अधिकृत प्रशासन	सामाजिक उद्देश्य तथा संस्थागत मिशन
योगदान	नीति, व्यापक सेवाएँ और संबंधित नियमन	स्थानीय पहुँच, सहयोग और विशेष कार्यक्रम
संसाधन	सार्वजनिक बजट तथा अधिकृत व्यवस्था	अनुदान, दान और अन्य अनुमत संसाधन
जवाबदेही	सार्वजनिक प्रशासन और वैधानिक ढाँचा	संगठन की व्यवस्था तथा लागू दायित्व

पूरक भूमिकाएँ

सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र सेवा दे सकता है और **NGO** समुदाय को वहाँ पहुँचने में सहयोग कर सकता है। स्थानीय संस्था भाषा की बाधा समझ सकती है, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था बड़े क्षेत्र के संसाधन का समन्वय कर सकती है।

जिम्मेदारी की स्पष्टता

साझेदारी में कार्यक्षेत्र, सेवा मानक, सूचना साझा करने की सीमा, रेफरल और समीक्षा तय होनी चाहिए। सरकारी कार्यक्रम का नाम उपयोग करने से कोई संस्था अपने-आप अधिकृत सेवा प्रदाता नहीं बन जाती।

UN संस्थाओं से अंतर

WHO, **UNICEF** और **UNFPA** संयुक्त राष्ट्र तंत्र की अलग प्रकृति वाली संस्थाएँ हैं। इन्हें सामान्य अंतरराष्ट्रीय **NGO** की सूची में नहीं रखा जाता।

> साझेदारी का अर्थ संस्थाओं की पहचान समाप्त होना नहीं; सहयोग की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट होना है।

सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की योजना

Planning a Community Health Programme

योजना के प्रमुख चरण

1	जरूरत समझना	समुदाय और उपलब्ध सेवा की स्थिति का आकलन।
2	उद्देश्य तय करना	स्पष्ट और वास्तविक परिणाम की दिशा।
3	संसाधन जुटाना	कार्यकर्ता, समय, धन और आवश्यक सहयोग।
4	कार्य करना	भूमिका, सेवा की गुणवत्ता और रेफरल की व्यवस्था।
5	समीक्षा करना	परिणाम और समुदाय की प्रतिक्रिया से सुधार।

आवश्यकता का आकलन

स्थानीय लोगों से बातचीत, उपलब्ध सेवा की समीक्षा और उपयुक्त जानकारी से समस्या समझी जाती है। केवल दाता की पसंद के आधार पर कार्यक्रम तय करने से समुदाय की वास्तविक जरूरत छूट सकती है।

उद्देश्य और गतिविधि

“स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना” एक गतिविधि है। “चयनित समुदाय को आवश्यक जाँच और आगे की सेवा तक पहुँचाना” उसका उद्देश्य हो सकता है। गतिविधि और परिणाम को अलग समझना आवश्यक है।

समीक्षा

उपस्थिति के साथ सेवा की गुणवत्ता, रेफरल पूरा होना और समुदाय का अनुभव भी देखें। कोई जाँच शिविर उपयोगी तभी है जब आवश्यक आगे की सेवा का रास्ता हो।

> अच्छा कार्यक्रम जरूरत, उद्देश्य, संसाधन, कार्रवाई और समीक्षा को एक साथ जोड़ता है।

स्वयंसेवक और प्रशिक्षित कार्यकर्ता

Volunteers and Trained Workers

स्वयंसेवक की भूमिका

स्वयंसेवक (**Volunteer**) समय, कौशल और सहयोग देकर संगठन के उद्देश्य में योगदान करता है। उसे कार्य की सीमा, संवाद, गोपनीयता और सुरक्षित व्यवहार की जानकारी मिलनी चाहिए।

कार्य	आवश्यक तैयारी
जागरूकता	सही संदेश तथा संवाद कौशल
पंजीकरण	न्यूनतम आवश्यक सूचना और गोपनीयता
सेवा से जोड़ना	उपलब्ध सेवा और रेफरल की जानकारी
राहत सहयोग	सुरक्षा, वितरण और जिम्मेदारी की स्पष्टता
प्राथमिक उपचार	उपयुक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण

पेशेवर काम की सीमा

जाँच का चिकित्सकीय अर्थ समझाना, निदान करना और दवा लिखना योग्य तथा अधिकृत पेशेवरों के कार्य हैं। सेवा भावना इनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण और अधिकार का विकल्प नहीं है।

सहायता और पर्यवेक्षण

कार्यकर्ता को जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ व्यक्ति या पेशेवर से संपर्क करने का स्पष्ट तरीका मिलना चाहिए। गलत सूचना या समस्या को छिपाना संगठन की गुणवत्ता को कमजोर करता है।

देखभालकर्ता का स्वास्थ्य

लंबे कार्य, संकट और भावनात्मक दबाव से कार्यकर्ता प्रभावित हो सकता है। उचित आराम, सहयोग और सुरक्षित कार्य व्यवस्था आवश्यक हैं।

> स्वयंसेवा में उत्साह के साथ प्रशिक्षण, सीमा की समझ और जवाबदेही भी चाहिए।

संसाधन, पारदर्शिता और जवाबदेही

Resources, Transparency and Accountability

संसाधनों का उपयोग

संगठन को धन के साथ प्रशिक्षित मानव संसाधन, स्थान, उपकरण, जानकारी और समय की आवश्यकता होती है। संसाधन का उपयोग संस्था के उद्देश्य तथा स्वीकृत योजना के अनुसार होना चाहिए।

पारदर्शिता के प्रमुख आधार

- आय, व्यय और गतिविधियों का उपयुक्त अभिलेख।
- जिम्मेदारियों और निर्णय प्रक्रिया की स्पष्टता।
- सेवा की गुणवत्ता तथा उपयोग की समीक्षा।
- शिकायत और प्रतिक्रिया देने की सुविधा।
- हितों के टकराव की पहचान और उचित प्रबंधन।

प्रशासनिक खर्च

प्रशिक्षण, अभिलेख, सुरक्षा और निगरानी पर उचित खर्च सेवा की गुणवत्ता का भाग है। केवल न्यूनतम प्रशासनिक खर्च को संगठन की प्रभावशीलता का पूरा प्रमाण नहीं माना जा सकता।

परिणाम का आकलन

गतिविधि (**Activity**), प्रत्यक्ष उपलब्धि (**Output**) और परिणाम (**Outcome**) अलग हैं। स्वास्थ्य बैठक आयोजित करना गतिविधि, लोगों तक पहुँचना उपलब्धि और आवश्यक सेवा का उपयोग बढ़ना परिणाम हो सकता है।

समुदाय के प्रति जवाबदेही

दाता के साथ उन लोगों के प्रति भी जिम्मेदारी है जिनके लिए संस्था काम करती है। उनकी शिकायत, पसंद और अनुभव की समीक्षा आवश्यक है।

> पारदर्शिता और गुणवत्ता संगठन की सेवा पर विश्वास बढ़ाने के प्रमुख आधार हैं।

स्वास्थ्य सेवा में नैतिकता और गरिमा

Ethics and Dignity in Health Services

सम्मानपूर्ण सेवा

स्वास्थ्य सहायता में व्यक्ति की गरिमा, भाषा, संस्कृति, गोपनीयता और निर्णय की क्षमता का सम्मान किया जाना चाहिए। सहायता पाने के लिए अपमान, अनावश्यक प्रचार या निजी जानकारी का खुलासा स्वीकार करना शर्त नहीं होना चाहिए।

सिद्धांत	व्यवहार में अर्थ
सूचित सहमति (**Informed Consent**)	आवश्यक जानकारी समझाकर उचित सहमति लेना
गोपनीयता (**Confidentiality**)	निजी जानकारी की सुरक्षा
भेदभाव से सुरक्षा	जरूरत के अनुसार समान अवसर
न्यूनतम सूचना	कार्य के लिए आवश्यक जानकारी ही जुटाना
सुरक्षा	नुकसान और शोषण के जोखिम को कम करना

तस्वीर और निजी जानकारी

स्वास्थ्य स्थिति, नाम और तस्वीर का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। सेवा की सहमति और प्रचार की सहमति एक ही बात नहीं हैं। बच्चों तथा संवेदनशील परिस्थितियों वाले व्यक्तियों की सुरक्षा विशेष महत्त्व रखती है।

शिकायत का अवसर

व्यक्ति को सेवा के बारे में प्रश्न, असहमति और शिकायत रखने का अवसर मिलना चाहिए। शिकायत करने से सेवा से वंचित होने का डर गुणवत्ता की समीक्षा को कमजोर करता है।

> अच्छा मानवीय कार्य सहायता के साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान को बनाए रखता है।

स्वैच्छिक क्षेत्र की क्षमता और सीमाएँ

Strengths and Limitations

प्रमुख क्षमताएँ

स्थानीय संपर्क, लचीली कार्यविधि, विशेष विषय की विशेषज्ञता और समुदाय से विश्वासपूर्ण संबंध गैर-सरकारी संगठन की उपयोगी क्षमताएँ हो सकती हैं। स्थानीय अनुभव नीति तथा सेवा सुधार में भी योगदान देता है।

प्रमुख सीमाएँ

सीमा	संभावित प्रभाव
अस्थिर वित्त	सेवा की निरंतरता में बाधा
सीमित कर्मचारी	कार्यक्षेत्र और गुणवत्ता पर दबाव
कमजोर समन्वय	दोहराव या लोगों का सेवा से छूटना
अपर्याप्त प्रशिक्षण	गलत जानकारी और अनुचित कार्य
बाहरी प्राथमिकताएँ	स्थानीय जरूरत की उपेक्षा

सीमाएँ कम करने के उपाय

उचित योजना, प्रशिक्षित कर्मचारी, स्पष्ट साझेदारी, समुदाय की भागीदारी और नियमित समीक्षा से कार्य बेहतर हो सकता है। जिन सेवाओं की क्षमता नहीं है, उनके लिए उचित रेफरल व्यवस्था चाहिए।

उपलब्धि का संतुलित मूल्यांकन

संगठन की प्रसिद्धि या बड़े अभियान के आधार पर हर स्थानीय सेवा की गुणवत्ता समान मानना उचित नहीं है। उसके कार्य, सुरक्षा, जवाबदेही और वास्तविक परिणाम की समीक्षा करें।

> **NGO** की क्षमता महत्त्वपूर्ण है; स्थायी सुधार के लिए सार्वजनिक व्यवस्था और समुदाय का समन्वय भी आवश्यक है।

प्रमुख भारतीय संगठनों का सार

Major Indian Organizations: A Summary

संगठन	स्थापना	प्रमुख पहचान
भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी	1920	राष्ट्रीय मानवीय सहायता और स्वास्थ्य सहयोग
सेंट जॉन **Association**	1912	प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण
सेंट जॉन **Brigade**	1928	संगठित स्वैच्छिक सहायता
FPA India	1949	यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य
TAI	1939	क्षयरोग से जुड़े स्वैच्छिक प्रयास
KGNMT	1945	ग्रामीण महिला और बाल कल्याण
VHAI	1970	स्वैच्छिक स्वास्थ्य महासंघ
IMA	1928	चिकित्सकों का पेशेवर संघ
ICCW	1952	बाल कल्याण
HelpAge India	1978	वृद्ध व्यक्तियों का कल्याण
LEPRA Society	1989	चयनित रोग, समावेशन और पुनर्वास

कुष्ठ निवारण का सहयोग

HKNS की प्रमुख पहचान कुष्ठ रोग से जुड़े स्वैच्छिक और सामाजिक कार्य से है। संस्था का अध्ययन केवल वर्ष के आधार पर नहीं; उद्देश्य और योगदान के साथ करें।

> एक विषय पर काम करने वाले दो संगठन आवश्यक रूप से एक ही संस्था या एक ही कार्यक्रम नहीं होते।

अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सार

International Organizations and Key Concepts

संगठन	ऐतिहासिक आरंभ	प्रमुख कार्य की दिशा
ICRC	1863	संघर्ष में मानवीय सहायता और संरक्षण
IFRC	1919	राष्ट्रीय सोसायटियों का सहयोग और आपदा कार्य
IPPF	1952	प्रजनन स्वास्थ्य के सदस्य संघों का महासंघ
CARE	1945	राहत तथा स्वास्थ्य से जुड़ा सामाजिक विकास
MSF	1971	स्वतंत्र चिकित्सा मानवीय सहायता
Save the Children	1919	बाल स्वास्थ्य, विकास और संरक्षण

आवश्यक अवधारणाएँ

- गैर-लाभकारी संगठन में आय और कर्मचारी हो सकते हैं; संसाधन सामाजिक उद्देश्य के लिए उपयोग होते हैं।
- सरकारी अनुदान मिलना अपने-आप सरकारी विभाग बनना नहीं है।
- **ICRC**, **IFRC** और राष्ट्रीय सोसायटियाँ रेड क्रॉस आंदोलन के अलग घटक हैं।
- **IMA** पेशेवर संघ है; **NMC** की भूमिका नियामक है।
- **WHO** और **UNICEF** संयुक्त राष्ट्र तंत्र की संस्थाएँ हैं; इन्हें सामान्य **NGO** नहीं कहा जाता।

अध्याय का केंद्रीय विचार

स्वास्थ्य में गैर-सरकारी क्षेत्र सेवा, जागरूकता, सहभागिता और पुनर्वास से योगदान देता है। उसकी प्रभावशीलता विशेषज्ञता, नैतिकता, स्थानीय जरूरत और अन्य संस्थाओं से समन्वय पर निर्भर करती है।

> पहचान के लिए नाम और वर्ष के साथ संस्था की प्रकृति, कार्य और सहयोग का स्तर समझें।